

喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用

北京市顺义区第二医院(101309) 别意玲

摘要 目的 介绍喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用,为临床医生提供警示,预防该类不良反应的发生。方法 通过查阅文献总结多年来不良反应报告及药物相互作用。结果 该类药物在临床应用,在骨骼、皮肤、心脏、中枢神经系统等均报告出现不良反应,并与多种药物发生相互作用。结论 喹诺酮类药物为临床常用抗感染药物,对其不良反应及药物相互作用应尤为引起注意。

关键词 喹诺酮 药物不良反应 药物相互作用

1. 药物不良反应

1.1 过敏反应及光毒性反应^[1-3]

发生在个别特异体质者。主要表现为皮疹、荨麻疹、皮炎和剥脱性皮炎等,以环丙沙星和诺氟沙星为多。此类反应大都较重,一般发生在服药后几天至数周后,可见哮喘、呼吸困难、喉头水肿、血管性水肿、过敏性脉管炎和过敏性休克等严重过敏反应。谢腾芳报道1例男性上呼吸道感染患者,使用氧氟沙星冻干粉针0.2g加入5%葡萄糖250ml静滴3min后,患者出现舌根发麻、颈、后背发凉,心慌胸闷,面色发白,呼吸急促,立即停止输液,随之患者神志不清,尿失禁,口唇发紫、抽搐,四肢厥冷,血压心率均未测出,诊断为过敏性休克。经抢救后恢复正常出院。喹诺酮类药物引起的光毒性与药物结构、阳光照射、自身的敏感性有密切关系。有报道其中以母核的8位氟原子取代光毒性最大,8位甲氧基取代物光毒性最小。喹诺酮药吸收后,使紫外线能量大部分在皮肤中释放,由光激发而致皮肤细胞的损伤,表现为红斑、水肿、疼痛、脱屑、褪皮、皮疹、水泡和色素沉着,严重者可能被灼伤。故敏感体质者服药期间应避免紫外线和日光的照射,或变换给药时间(睡前)。光敏反应多见于氟

罗沙星、洛美沙星和司帕沙星,尤以后两者引起者程度较严重,最近实验动物中洛美沙星可诱发皮肤癌,美国亦已向医师发出通知。

1.2 对中枢神经系统的作用

喹诺酮类药物治疗过程中,对中枢神经系统的不良反应报道日益增多。其临床表现为头痛、头晕、失眠、兴奋、失语,还有极少数可发生手足麻木、手指颤抖、幻觉和癫痫。发生的机制可能是:氟喹诺酮类抗菌药物分子结构中含有氟原子,具有一定的脂溶性,能透过血脑屏障进入脑组织,使中枢神经系统兴奋性增高。李晓兵报道一女性阑尾炎患者,口服甲磺酸左氧氟沙星1片(0.1g)后10min出现口周、四肢麻木感,四肢抽搐,查体神志清,精神紧张,呼吸急促,大汗,双瞳孔等大等圆对光反射存在,颈无抵抗,四肢呈痉挛性抽搐,伴不自主运动,间断加重,病理反射未引出。吸氧,静脉给予5%葡萄糖加地塞米松10mg,10min后好转,1h后症状完全消失。故有精神病和癫痫病史者应忌用。

1.3 软骨、肌腱毒性

主要在幼龄动物中出现关节软骨损害,虽在人类中尚未发现,但少数病例出现严重关节疼痛和炎症。因此,喹诺酮类药物不宜用于骨骼系统尚未发育完全的16岁以下的人群,孕妇禁用,乳母服药期间应停止哺乳。据近期Drug报道,培氟沙星等可导致跟腱炎症,约半数均为双侧,合用皮质激素为危险因素,严重者可引起跟腱断裂。可能与本类药物引起肌腱的胶原组织缺乏和缺血性坏死有关。另有龙小华等报道1例左氧氟沙星致关节反应性滑膜炎一女性慢性宫颈炎、子宫内膜炎患者,口服左氧氟沙星片0.2g, bid,次日上午服药后即感到右肘关节疼痛,并发展至双手掌指关节、右膝、双脚后跟疼痛难忍,且关节处皮温升高,第3天出

现掌指关节红肿,关节活动受限伴右手颤动,晚失眠。立即停药,给予对症治疗恢复正常。

1.4 对心脏的毒性

喹诺酮类药物(主要为第4代)可能引起心电图Q-T间期延长,具有心电图QT间期延长的高危因素患者、电解质紊乱患者和使用明显具有QT间期延长的药物(如三环类抗抑郁药、奎尼丁、胺碘酮等药物)的患者应慎用。

1.5 对肝脏的毒性

大量或长期应用该类药易致肝损害,使谷草转氨酶、谷丙转氨酶和乳酸脱氢酶等升高,表现为药物性黄疸,巩膜、皮肤和黏膜黄染。任来春报道1例,21岁上呼吸道感染的男性患者,给予0.2g氧氟沙星100ml+20ml双黄连注射液静脉注射出现腹痛、恶心、呕吐、尿液浓茶样,皮肤巩膜黄染肝功酶升高,停药对症治疗,5天后症状消失,治愈出院。故氧氟沙星与双黄连注射液合用应慎重。

1.6 对肾脏的毒性

本类药物大都以原形从尿中排泄,其尿液浓度高于血浓度5~6倍,对肾脏可造成不同程度的损害,主要有血尿、结晶尿等。有的患者还可出现高尿酸血症,过敏性间质性肾炎或少尿性肾衰。吴抗美报道1例前列腺炎男性患者,静脉滴注0.2%氧氟沙星注射液时,出现尿闭,腰部针刺状剧烈疼痛,并向下腹部大腿内侧放射,恶心、呕吐、面色苍白。立即停止输液,进行对症治疗后好转。氧氟沙星注射液80%在肾脏排泄,且溶解度小,更易产生结晶尿。多饮水或服利尿药,造成大量稀释尿,是治疗结晶尿的有效措施。

1.7 对糖代谢的影响

据国外的报道,加替沙星在糖尿病患者中引起低血糖的比例达到6.4/1000例,高血糖则高达13/1000例。对无糖尿病患者也有一定的致血糖紊乱作

小金丸致过敏反应 3 例

北京大学人民医院(100044) 唐恺

例 1, 患者, 女, 28 岁。既往无药物过敏史。因乳腺增生口服小金丸 3g, 每日 2 次。次日晚服药后约 1h 患者全身出现红色皮疹, 连成片。第 3 天凌晨出现胸闷、低热, 来院就诊。查体: 体温 37.6℃, 四肢、胸背部及躯干为红色小丘疹, 连成片, 诊断为药物过敏。处理: 停药, 给予 0.9% 氯化钠注射液 500ml+地塞米松注射液 10mg 静脉滴注。2 天后症状好转。

例 2, 患者, 女, 45 岁。既往无药物过敏史。因乳腺增生口服小金丸 1.8g, 每日 2 次。服用 2 次后出现过敏反应, 来院就诊, 轻痒查体: 双下肢界限欠清、弥漫性、潮红性红斑, 肿胀, 部分区域皮温升高,

压痛(+), 腰部、背部部分区域也有压痛(+). 给予抗组胺药仙特明 10mg, 每日 1 次口服, 服药后症状逐渐好转。

例 3, 患者, 女, 37 岁。既往无药物过敏史。因乳腺增生口服小金丸 1.2g, 每日 2 次。服用 2 次后四肢出现皮疹, 随后逐渐加重, 背部、胸腹部也出现皮疹且伴随瘙痒症状。即停药, 停药后症状逐渐消失。

讨论 由于小金丸中地龙、木鳖子等含有大量动植物蛋白、多肽等大分子物质, 属于完全抗原, 当异体蛋白进入体内, 刺激机体产生相应的抗体, 当抗原物与之再接触时, 即发生过敏反应。

具有过敏性体质的患者, 对于药物反应性与众不同, 出现不良反应与剂量无关, 由个体差异所致。而以上 3 例病例中的患者均既往无药物过敏史, 但她们服用剂量的不同, 导致了过敏反应的程度不同。由此可提示医生: 对于有药物过敏史的患者应慎用小金丸, 而对于无药物过敏史的患者在首次使用小金丸时, 可先从最小治疗量开始, 以便观察其有无过敏反应。一旦在使用小金丸过程中发生不良反应, 首先应予以停药观察, 如果症状未有好转, 可服用脱敏药(如: 扑尔敏等)治疗。

(20070218 收稿)

用, 引起低血糖的比例为 0.3 / 1000 例, 高血糖为 0.07 / 1000 例。引起血糖紊乱的机理尚不清楚, 一般发生在用药后的第 4~10 天。因此, 对于老年患者及糖代谢紊乱者, 尤其肾功能不全的糖尿病患者应慎用, 在治疗期间应严密监测患者血糖的变化。

1.8 对胃肠道的作用

一般表现为恶心、呕吐、食欲不振、腹痛腹泻等, 且剂量愈大不良反应发生率愈高, 最严重的病例是消化道出血, 长期应用可致细菌性腹泻。

2. 药物相互作用

2.1 与其他抗菌药物合用

2.1.1 β -内酰胺类可阻碍细胞壁粘肽的合成, 造成细胞壁缺损, 从而使喹诺酮类易于发挥杀菌作用。

2.1.2 氨基糖苷类药物与喹诺酮类药物对革兰氏阴性菌均有良好的抗菌活性, 通过抑制 DNA 回旋酶并阻碍细胞蛋白质的合成的双重作用方式以发挥其协同作用, 尤其在用于大肠杆菌引起的感染时药效增加。

2.1.3 诺氟沙星与磷霉素合用治疗耐

药伤寒, 疗效明显优于单用诺氟沙星者, 同时对绿脓杆菌引起的感染亦有良好作用。

2.1.4 与磺胺嘧啶合用, 明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌的作用。

2.1.5 利福平是肝药酶诱导剂, 而喹诺酮类具有较强的肝药酶抑制作用, 合用后致使喹诺酮类抗菌活性降低甚至消失。

2.1.6 与万古霉素合用可能导致毒性增加, 出现肾小管上皮损害, 蛋白尿等中毒症状。

2.1.7 与氯霉素、红霉素合用可致效用降低, 同时, 对肝、肾功能及神经系统的不良反应可能进一步加重。

2.1.8 环丙沙星与阿霉素、呋喃妥因合用, 增加了其毒性, 并对肾功能不全者损害更大。

2.2 与其它类药物的相互作用

喹诺酮类药物抑制茶碱类药物的代谢, 使茶碱血浓度升高, 导致茶碱中毒, 老人尤易发生, 因此不宜与茶碱类药物合用; 碱性药物、抗胆碱药、H₂受体阻滞剂(西米替丁、雷尼替丁、奥美拉唑等)均可降低胃液酸度, 从而减少本类药物的吸收, 故应避免同服; 不宜与碱化剂同时服

用; 含钙、镁、铝的抗酸剂由于阳离子与喹诺酮类药物的 4-酮氧基-3-羟基发生络合反应, 可降低本类药的吸收利用, 故应避免合用; 本类药与 GABA 合用时相互作用, 产生多种精神症状, 易诱发癫痫; 也不宜与抗惊厥药合用; 与非甾体抗炎药(如布洛芬、芬布芬、舒林酸等)合用, 可引起中枢性痉挛发作; 与口服抗凝血药物如华法令同时使用有增加出血的危险。

喹诺酮类药物是近年来迅速发展起来的抗菌药物, 具有抗菌谱广、抗菌力强、给药方便、与其它常用抗菌药物无交叉耐药性, 成为竞相生产和临床应用的热点药品, 亦使其新的 ADRs 时有发生。因此临床医生必须掌握药物的耐药性、不良反应、相互作用、药物的疗效, 以减少医疗纠纷的发生。参考文献

- 1 谢腾芳. 氧氟沙星致过敏性休克 1 例[J]. 中国医院药学杂志, 2005, 25(8): 792
- 2 邹卫. 左氧氟沙星的不良反应[J]. 中国医院药学杂志, 2003, 23(12): 767
- 3 刘绍莉. 口服左氧氟沙星胶囊致严重皮肤过敏反应 1 例[J]. 中国医院药学杂志, 2006, 26(6): 739

(20070301 收稿)